جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : عبير جمعه عبدالرازق عبد العظيم

المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** الهرم **العنوان :** الهرم

رقم البطاقة : 29112012109221 **رقم التليفون :** 01101926458 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 21-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 01-12-1991**المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(--------------------------) **التوقيع:(--------------------------)**

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ---------------------------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني	**الوظيفة:** ---------------------------	**التوقيع:** د/ محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن	**الوظيفة:** ---------------------------	**التوقيع:** د/ ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان	**الوظيفة:** ---------------------------	**التوقيع:** نرمين رمضان

جوستاف روسي

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ------------------------ **ا.د/** ------------------------ **د/** ------------------------ **د/** ------------------------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : --

خطة العلاج : --

المستشفي : ---**قسم :** ---

جهة العلاج : ---**نفقات :** ---

ملاحظات : --

رئيس **المجلس الطبي المتخصص**	**مدير عام** **مديرية الشئون الصحية**	**ختم** **شعار الجمهورية**

Name: عبير جمعه عبدالرازق عبد العظيم
National ID: 29112012109221

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL
EGYPTE

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

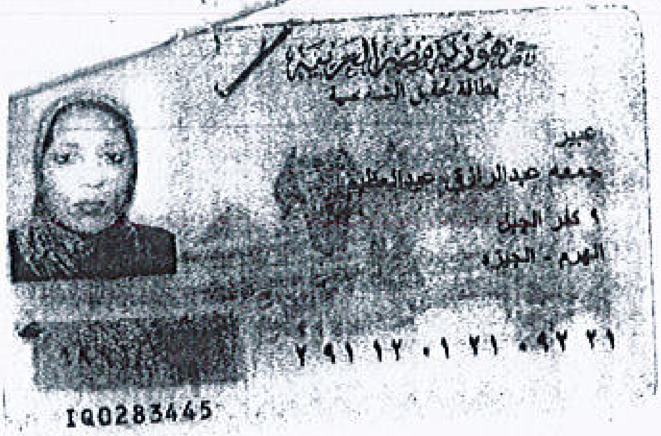
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : yyyy-mm-dd --:-- --	**تاريخ وساعة الخروج :** 05-07-2026 01:17 PM

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

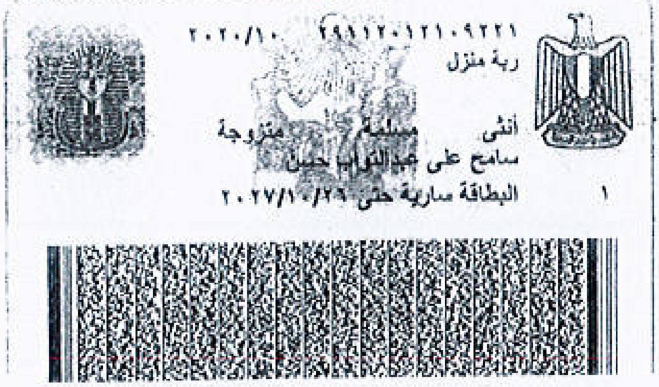
عبير
جمعه عبدالرازق عبدالعظيم
٩ كفر الجبل
الهرم - الجيزة

٢٩١١٢٠١٢١٠٩٢٢١

IQ0283445

٠١١٠٢٩٣٦٤٠٥٨
٠١١٥٧٦٢٣١٩٧

تم عمل
ابراهيم
٢٤/٢/١٢



٢٩١١٢٠١٢١٠٩٢٢١ ٢٠٢٠/١٠
ربة منزل
أنثى مسلمة متزوجة
سامح على عبدالتواب حسن
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/١٠/٢٩

DMS

تعميم
مقاطعة

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient ID: 95479	Patient Name English: Abeer Gumaah Abdalrazek
٣٤ سنة، ٥ شهر Age:	2026/05/18 10:09:10 AM :Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary:33 years old female patient with right breast lump.

Detailed Findings

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The right breast shows retroareolar ill-defined spiculated dense mass lesion with obscured margins and architectural distortion
- Dense UOQ dense mass lesion
- **Ultrasound** revealed large ill defined retro areolar irregular mass lesion measures17x11mm (index lesion)
- A rounded rather well defined_hypoechoic mass lesion vs pathological lymph node located at 10 o'clock zone c measures about 7x7mm
- A third lesion located at 8 o'clock zone a measures7x4mm
- A fourth lesion located at 7 o'clock zone c measures10x8mm
- Normal nipple/areolar complex.
- A solitary enlarged pathological axillary lymph nodes at level I, with effaced hila, measures about 14x10mm with cortical thickness of 5mm mm.

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- Multiple small dispersed subcentimetric thin-walled anechoic cysts.
- 2 small hypoechoic well defined mass lesion likely benign in nature located retroareolar measures 3mm and at 8oclock zone a measures 7x4mm
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Right breast (BIRADS 5): Right multicentric neoplastic process with pathological lymph node as described For tru cut biopsy and dynamic MRI breast study.**
- **Left breast (BIRADS 2): left breast benign looking lesions as described likely fibroadenomata**

Dr. Marwa a. el seoud

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Patient Name	عبير جمعه عبدالرازق 0	**Code Number**	**YK 262469**
Sex/Age	Female 34Y	**Patient ID**	**19995**
Registered Date	**20/05/2026 15:24:41**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	11/06/2026 17:25:30	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**6/14/2026, 12:48:38 PM**		

BREAST and BIOMARKERS

Clinical Data: Right breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 20/05/2026, at 1:05 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.
Gross Examination: Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.2 cm & 0.7 cm long, totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9) & SISH.

Microscopic examination:
- Histologic type: Invasive duct carcinoma
- Histologic grade: 2 (differentiation 2, pleomorphism 2, mitosis 2)
- DCIS: Intermediate grade DCIS, cribriform pattern.
- Microcalcification: Absent.
- Angioinvasion: Present.
- Perineural invasion: Absent.
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Moderate.

Results:
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 20% of tumor cells (score 6/8).
- Her2: Intermediate complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 2+).
- SISH: Amplified (Average Her2 copy No.: (4.5), Her2/CEP17 ratio: (2.2)).
- Ki67%: 50%.

Conclusion:
Right breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, Grade 2.
- Intermediate grade ductal carcinoma in situ, cribriform pattern.

IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 6/8).
- Her2: Equivocal (score 2+).
- SISH: Amplified, Group I (Average Her2 copy No.: (4.5), Her2/CEP17 ratio: (2.2)).
- Ki67%: 50%.

**Scoring system: "ER, PR"

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name: abeer gomaa.
Date: 17/5/2026.

BILATERAL SONOGRAPHY

- Normal fibro-glandular parenchyma is seen, (ACR-**C**).
- The left breast shows retro-areolar medium density mass with partially defined partially obscured margins.
- No suspicious clustered micro-calcification is seen.
- Normal skin thickness, subcutaneous fat and nipple areolar complex.

COMPLEMENTARY BREAST ULTRASOUND:-.

- Bilateral breasts are of heterogeneous parenchymal texture, mostly glandular.
- **The right breast shows well defined hypo-echoic solid mass with macrolobulated margin, seen at the retro-areolar region showing heterogeneous texture with anechoic areas of cystic changes and hyper echoic areas as well. The lesion is measuring about 2.7x1.5x2.0 cm in dimensions. By Doppler study it shows internal vascularity. By Micorpure technique its shows calcifications.**
- No dilated lactiferous ducts.
- Normal skin thickness & subcutaneous fat lobules
- Both axillae show enlarged LNs with preserved echogenic fatty hilum.

OPINION:

- right breast suspicious looking lesion as described.
  Histopathological assessment is recommended. (BIRADS **IV a**)

MUCH Obliged,

DR. walaa ahmed. MSc.

يوجد ورم بالثدى الايسر
[illegible] بالثدى
Rt

L.N. 14 X 10
index 17 X 11
at 10 2.c 7X7 L.N ??
at 8 2. a 7X4
1.0X8

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول الرقمى

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

رسوم الاستعلام 20 جنية

جهه الاصدار :فرع الجيزة

تاريخ الاصدار :18-5-2026

الى من يهمه الامر ....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) عبير جمعه عبدالرازق بطاقة رقم 29112012109221

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعه :18-5-2026

الموظف المختص
[illegible]

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 1978451

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

Non-HIO Letter
[[DOCTYPE:NON_HIO_LETTER]]

[illegible]
١٨ - ١٠

مبـــادرة رئيس الجمهوريـة
لدعـم صحة المرأة المصرية

10/18/2026 ☐

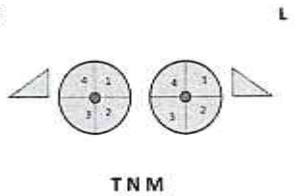
MDT FORM

Name:	عبير جمعه عبدالرازق عبدالعظيم	**MRN:**	11669
Age:	35 Y	**ID:**	29112012109221
Menopausal Sta	PRE	**Phone:***	01101926458
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	-VE FH
Gender			
CO Morbidity:	M.FREE	**Reason Of MDT:**	NEW CASE
Surgical History:*	NAD	**ECOG Performance Status**	○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4

Clinical Data:

BX: RT. IDC G2

ER: 8/8 **PR:** 6/8 **HER2:** AMPLIFI **KI67:** 50%



T N M

Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

History:

Sonomammography:

SM ACR B
RT RETROAREOLAR MASS WITH ARCHITECTURAL DISTORTION
1,7*1,1 MM (INDEX LESION)
AT 10 OCLOCK MASS VS PATHOLOGICAL LN ZONE C 7*7 MM
THIRD LESION AT 8 OCLOCK 7*4 MM
FOURTH LESION AT 7 OCLOCK 10*8 MM
WITH SOLITAR PATHOLOGICAL LN CORTICAL THICKNESS 5 MM BIRADS 5
RT MULTICENTREC NEOPLASTIC PROCESS
LT BENGIN LESION LIKELY FIBROADENOMATA BIRADS 2
MRI ACR C
RT MULTIPLE LOQ MASSES 15*16 MM WITH HETEROGENEOUS CONTRAST ENHANMENT
RT AXIILARY LN BIRADS 6

Clinical Staging:

CT2NOMO
MULTI CENTRIC

Pathological Staging:

Biomarker/Molecular

Mets Workup:

CT CAP free

Recommendations:

FOR POSSIBILTY OF NACT THEN RT SM & SLNB

MDT Outcome & Plan

for neoadj TCHP 6 CYCLES THEN RT SM & SLNB

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د حنان عزت	د احمد نجيب		